

ДГМУ 2025

Доказательная медицина

Итоговый от 16.06.2025

#1

Сознательное, четкое и беспристрастное использование лучших из имеющихся доказательств при принятии решений о помощи конкретным больным, это одно из определений понятия:

биометрии

доказательной медицины

клинической эпидемиологии

медицинской статистики

клинической медицины

#2

С позиции доказательной медицины врач должен принимать решение о выборе метода лечения, на основании

информации из интернета

опыта коллег

статьи из рецензируемого журнала с высоким индексом цитируемости

статьи из неизвестного источника

#3

Пионером в разработке принципов доказательной медицины принято считать:

Бруссе

Кокран

Гавар

Фибигер

Луи

#4

Кто первым начал внедрять в медицинскую практику методы статистического анализа результатов вмешательств:

Бруссе

Кокран

Гавар

Фибигер

Луи

#5

Кому принадлежит первое описание контролируемых исследований:

Бруссе

Луи

Кокран

Гавар

Фибигер

#6

Кто разработал технологию выполнения мета-анализа клинических исследований, систематический обзор:

Бруссе

Кокран

Луи

Гавар

Фибигер

#7

Примерами необоснованного лечения не являются:

кровопускание

препарат Катрекс из акульеого хряща

аспирин при ИБС

увеличение физической активности при ИБС

электронная таблетка

#8

Показатель, характеризующий надежность информации, приведенной в научном журнале, это

индекс достоверности

индекс доверия

индекс значимости

индекс цитируемости

#9

Одной из предпосылок возникновения доказательной медицины, являлось:

ограниченность финансовых ресурсов, выделяемых на здравоохранение

появление новых врачебных специальностей

совершенствование методов научных исследований

развитие математической статистики

#10

Выборочная совокупность – это:

группа, состоящая из относительно однородных элементов, взятых в единых границах времени и пространства

совокупность, состоящая из всех единиц наблюдения, которые могут быть к ней отнесены в соответствии с целью исследования

часть генеральной совокупности, отобранная специальными методами и предназначенная для ее характеристики

всех единиц наблюдения, которые могут быть отнесены к ней в соответствии с целью исследования

#11

Репрезентативность — это:

достаточный объем генеральной совокупности

достаточный объем выборочной совокупности

непохожесть выборочной совокупности на генеральную

способность выборочной совокупности наиболее полно представлять генеральную

#12

Доказательный подход основан на:

законах Российской Федерации

личном мнении нескольких академиков

анализе научных данных

предчувствиях большинства врачей

#13

«Золотым стандартом» медицинских исследований называют:

перекрестные исследования

одиночное слепое исследование

рандомизированные контролируемые испытания

парные сравнения

поперечное исследование

#14

Метод, при котором ни больной, ни наблюдающий его врач не знают, какой из способов лечения был применен, называется:

двойной слепой

тройной слепой

одиночный слепой

плацебоконтролируемый

открытый

#15

Метод, при котором все знают, какой из способов лечения был применен, называется:

двойной слепой

тройной слепой

одиночный слепой

открытый

полное слепое

#16

Метод, при котором никто не знает, какой из способов лечения был применен, называется:

двойной слепой

тройной слепой

одиночный слепой

открытый

закрытый

#17

Безвредное неактивное вещество, предлагаемое под видом лекарства, которое не отличается от него по виду, запаху, текстуре, называется:

биодобавка

аналог исследуемого препарата

гомеопатический препарат

плацебо

оригинальный препарат

#18

Контролируемое испытание, это исследование:

ретроспективное

проспективное

поперечное

перпендикулярное

одномоментное

#19

Исследование, в котором пациент не знает, а врач знает, какое лечение получает пациент, называется:

плацебоконтролируемым

двойным слепым

тройным слепым

простым слепым

открытым

#20

Исследование со случайно отобранной контрольной группой и наличием воздействия со стороны исследователя, называется:

рандомизированное контролируемое клиническое испытание

нерандомизированное исследование

обсервационное исследование

ретроспективное исследование

клиническое исследование

#21

В понятие «золотого стандарта» входят:

двойные-слепые плацебо-контролируемые рандомизированные исследования

простые нерандомизированные исследования

тройные слепые исследования

двойные-слепые нерандомизированные исследования

неконтролируемое исследование

#22

Исследование, в котором пациенты распределяются по группам случайным образом, называется:

простое слепое

нерандомизированное

плацебоконтролируемое

рандомизированное

двойное слепое

#23

Случайный отбор наблюдений носит название:

рандомизация

медиана

мода

вероятность

стратификация

#24

По степени открытости данных, исследование может быть:

открытым или слепым

закрытым или слепым

открытым или рандомизированным

рандомизированным или мультицентровым

параллельным или перекрестным

#25

Испытание фармацевтического препарата проводилось на базе лечебных учреждений различных городов РФ, это исследование является:

генеральное

множественное

полицентрическое

мультицентровое

федеральное

#26

В какой фазе клинических испытаний принимают участие здоровые добровольцы?

I фазе

II фазе

III фазе

IV (постмаркетинговой) фазе

фазе доклинических испытаний

#27

К группам методов медицинской статистики относятся:

сравнительная статистика

доказательная статистика

описательная статистика

математическая статистика

прикладная статистика

#28

Описательная статистика занимается:

сравнением полученных данных

набором материала

описанием и представлением данных

обоснованием полученных результатов

статистическим анализом

#29

Сбор данных может быть:

оптимизационным

статическим и динамическим

конструктивным и деструктивным

пассивным и активным

результативным

#30

Сравнительная статистика позволяет:

формулировать выводы в виде гипотез или прогнозов

проводить сравнительный анализ данных в исследуемых группах

проводить набор данных в соответствии с принципами рандомизации

представлять полученные результаты перед аудиторией

внедрить результаты исследования

#31

Вариационный ряд — это:

ряд числовых измерений признака, расположенных в ранговом порядке и характеризующихся определенной частотой

ряд цифровых значений различных признаков

генеральная совокупность

совокупность чисел

#32

Средняя арифметическая – это:

варианта с наибольшей частотой

разность между наибольшей и наименьшей величиной

обобщающая величина, характеризующая размер варьирующего признака совокупности

варианта, находящаяся в середине ряда

варианта с маленькой частотой

#33

Медиана – это:

варианта с наибольшей частотой

разность между наибольшей и наименьшей величиной

обобщающая величина, характеризующая размер варьирующего признака совокупности

варианта, находящаяся в середине ряда

варианта с маленькой частотой

#34

Сколько людей включает I фаза клинических испытаний:

около 100

200-600

700-900

тысячи пациентов

100-200

#35

Сколько людей включает II фаза клинических испытаний:

около 100

200-600

700-900

тысячи пациентов

50-100

#36

Сколько людей включает III фаза клинических испытаний:

около 100

200-600

тысячи пациентов

700-900

500

#37

При исследовании в одной группе:

все пациенты получают одно и то же экспериментальное лечение

пациенты 2х или более групп получают различное лечение

исследование, при котором обследование каждого пациента проводится однократно

исследование с наличием контрольной группы

#38

При исследовании в параллельных группах:

все пациенты получают одно и то же экспериментальное лечение

пациенты 2х или более групп получают различное лечение

исследование, при котором обследование каждого пациента проводится однократно

исследование с наличием контрольной группы

#39

Одномоментное исследование:

все пациенты получают одно и то же экспериментальное лечение

пациенты 2х или более групп получают различное лечение

исследование, при котором обследование каждого пациента проводится однократно

исследование, при котором экспериментальное и контрольное лечение получают одни и те же пациенты, с наличием периода отмывки

#40

Перекрестное исследование:

все пациенты получают одно и то же экспериментальное лечение

пациенты 2х или более групп получают различное лечение

исследование, при котором обследование каждого пациента проводится однократно

исследование, при котором экспериментальное и контрольное лечение получают одни и те же пациенты, с наличием периода отмывки

#41

Продольное исследование:

все пациенты получают одно и то же экспериментальное лечение

исследование с выделением группы людей, за которыми в течение некоторого времени наблюдают и повторно оценивают их состояние

исследование, при котором обследование каждого пациента проводится однократно

исследование, при котором экспериментальное и контрольное лечение получают одни и те же пациенты, с наличием периода отмывки

#42

В какой фазе появляются рандомизация и группа контроля:

I

II

III

IV

V

#43

Ракую фазу называют постмаркетинговой:

- I
- II
- III
- IV
- V

#44

В какой фазе участвуют здоровые люди:

- I
- II
- III
- IV
- V

#45

Наиболее надежные по достоверности результаты гозволяет получить

открытое исследование

исследование с «заслеплением» третьих лиц

двойное-слепое исследование

простое «слепое» исследование

полное слепое исследование

#46

Здоровые добровольцы участвуют в исследованиях

I фазы

IIa фазы

IIb фазы

III фазы

IV фазы

#47

Модель клинического испытания в одной группе обычно Используется в фазе исследования

I фазы

IIa фазы

IIb фазы

III фазы

IV фазы

#48

К технологии негативного контроля относится

контроль по архивной статистике

плацебо-контроль

активный контроль

контроль погрешностей

#49

Высшую степень в иерархии доказательной медицины занимает:

мета-анализ когортных исследований

систематический обзор рандомизированных клинических исследований

обсервационное клиническое исследование

рандомизированное клиническое исследование

исследование случай- контроль

#50

Для определения прогноза заболевания проводят поиск исследований:

рки

когортное исследование

исследование случай-контроль

систематические обзоры

литературные обзоры

#51

Рандомизированное клиническое исследование призвано ответить на вопросы:

лучший ли данный препарат, по сравнению с плацебо Или другим лекарственным препаратом, при данном заболевании

выяснить параметры достоверности и надежности

определить прогноз заболевания

определить этиологию заболевания

стоимость лечения

#52

В связи с чем можно утверждать, что в рандомизированном контролируемом исследовании (рки) пациенты, получающие плацебо, не подвергаются обману (неполучают должного лечения):

лечащий врач получает устное согласие пациента на проведение эксперимента

подписывает «информированное согласие пациента» (где предусмотрено его согласие на использование плацебо)

плацебо не оказывает вредного воздействия на организм, поэтому его применение не требует согласия пациента

подписывает согласие на госпитализацию

исследование нового препарата разрешено этическим комитетом

#53

Совокупность, состоящая из относительно однородных элементов, объединенных наступлением определенного признака, называется:

группой

когортой

классом

выборкой

отрядом

#54

Последнее место в «иерархии доказательств» занимает

исследования «случай-контроль»

когортные исследования

рандомизированные клинические исследования

систематические обзоры и мета-анализы

сообщения об отдельных случаях

#55

Первое место в «иерархии доказательств» занимает

исследования «случай-контроль»

когортные исследования

рандомизированные клинические исследования

систематические обзоры и мета-анализы

сообщения об отдельных случаях

#56

Материалы, соответствующие критериям высокого методического качества, представлены в базах данных:

clinicalevidence

embase

коокрановская библиотека

pubmed

medline

#57

Поиск систематических рефератов проверенного качества по всем имеющимся достоверным сведениям по определенной теме проводят:

medline

кокрановская база данных

embase

pubmed

clinicalevidence

#58

Международные проблемные группы занимаются:

составлением и обновлением кокрановских обзоров

анализом и обобщением данных, относящихся к различным клиническим разделам медицины по областям медицинской деятельности

анализом литературных обзоров

анализом статей

#59

Мультидисциплинарные группы занимаются:

составлением и обновлением кокрановских обзоров

анализом и обобщением данных, относящихся к различным клиническим разделам медицины по областям медицинской деятельности

применением специальных методов компиляции, оценки и обобщения результатов испытаний

анализом литературных обзоров

#60

Кокрановские рабочие группы по методологии обзоров занимаются:

составлением и обновлением кокрановских обзоров

анализом и обобщением данных, относящихся к различным клиническим разделам медицины по областям медицинской деятельности

применением специальных методов компиляции, оценки и обобщения результатов испытаний

анализом литературных обзоров

#61

Группы по областям интересов:

составляют и обновляют кокрановские обзоры

анализ и обобщение данных, относящихся к различным клиническим разделам медицины по областям медицинской деятельности

применение специальных методов компиляции, оценки и обобщения результатов испытаний

кокрановские подразделения, объединенные по таким аспектам, как условия оказания медицинской помощи, оказание помощи отдельным группам больных, различные уровни медицинской помощи

#62

Целью клинической эпидемиологии является:

разработка методов статистической оценки клинических наблюдений

исследование инфекционной заболеваемости

разработка и применение эффективных методов клинического исследования

предотвращение возникновения эпидемии и заразных заболеваний

#63

Исследования, опирающиеся на данные из прошлого это:

ретроспективные

проспективные

прошлогодние

поперечные

продольные

#64

Исследования, в которых сформированную в настоящем группу наблюдают в будущем это:

ретроспективные

проспективные

продольные

параллельные

открытые

#65

К экспериментальным исследованиям относятся:

«случай-контроль»

когортные

рки

одномоментные

ретроспективное

#66

Исследование, в котором изначально объединенную каким-либо общим признаком выделенную группу людей наблюдают в течение некоторого времени и сравнивают исходы у тех, кто был и не был подвергнут действию изучаемого вмешательства или другого фактора (т.е. экспонирован), либо был подвергнут ему в разной степени называют:

«случай-контроль»

когортные

рки

одномоментные

ретроспективное

#67

Исследования, в которых участники подвергаются однократному обследованию, обычно в течение относительно короткого периода времени, что позволяет в дальнейшем оценить распространенность того или иного исхода, течения заболевания, эффективности диагностики называют:

«случай-контроль»

когортные

рки

одномоментные

ретроспективное

#68

Формулярный список лекарственных средств является:

ограничительным

рекомендательным

законодательным

расширительным

определятельным

#69

В формулярном списке обязательно используются наименования лекарственных средств:

торговые

химические

генерические

принятые в данном лечебном учреждении

определенные клиническим фармакологом данного учреждения

#70

При составлении формулярного списка больницы необходимо собрать информацию об использовании лекарств в больнице:

список десяти главных по стоимости используемых лекарств

список зафиксированных побочных эффектов

данные о смертности в результате использования лекарств

примеры дублирования лекарств

список дженериков используемых в больнице

#71

К жизненно важным (vital) препаратам относят:

лекарства, важные для спасения жизни, имеющие опасный для жизни синдром отмены, постоянно необходимые для поддержания жизни

лекарства, эффективные при лечении менее опасных, но серьезных заболеваний

лекарства для лечения легких заболеваний

лекарства сомнительной эффективности

дорогостоящие лекарства с симптоматическими показаниями

#72

Необходимые (essential) это:

лекарства, важные для спасения жизни, имеющие опасный для жизни синдром отмены, постоянно необходимые для поддержания жизни

лекарства, эффективные при лечении менее опасных, но серьезных заболеваний

лекарства для лечения легких заболеваний

лекарства сомнительной эффективности

дорогостоящие лекарства с симптоматическими показаниями

#73

Второстепенные (non-essential) это:

лекарства, важные для спасения жизни

лекарства, имеющие опасный для жизни синдром отмены

лекарства постоянно необходимые для поддержания жизни

лекарства, эффективные при лечении менее опасных, но серьезных заболеваний

лекарства для лечения легких заболеваний, лекарства сомнительной эффективности, дорогостоящие лекарства с симптоматическими показаниями

#74

Фтк решает следующие вопросы:

мониторинг побочных эффектов

оценка использования лекарств

применение лекарств, находящихся на клинических испытаниях

отношения сотрудников больницы и представителей фармацевтических компаний и дистрибьюторов

#75

Формуляр — это

Справочник лекарственных средств

Закупочный список лекарств

Список жизненно-важных необходимых лекарственных средств

Справочник по специальности

Ограниченный список лекарственных препаратов, рекомендованный к применению в конкретной медицинской организации или на территории субъекта РФ

#76

Формулярный справочник (формуляр) — это:

Руководство по назначению (и отпуску) отобранных ЛП

Справочник лекарственных средств

Закупочный список лекарств

Список жизненно-важных необходимых средств

Справочник по специальности

#77

Формулярная система является:

Ограниченным списком лекарственных препаратов, рекомендованных к применению в конкретной медицинской организации или на территории субъекта РФ

Руководством по назначению (и отпуску) отобранных лекарственных препаратов

Системой контроля за движением ЛС, начиная с их поступления в аптеку, затем в отделение и до момента выдачи конкретному больному

Списком жизненно-важных необходимых лекарственных средств

Системой разработки и внедрения формуляров лекарственных препаратов в целях повышения качества лекарственного лечения и оптимизации затрат на оказание медицинской помощи

#78

Непрямые затраты на лечение включают:

затраты на приобретение лекарственных препаратов

затраты, связанные с использованием оборудования

затраты на оплату труда медицинских работников

затраты, связанные с потерей производительности

затраты, связанные с лечением осложнений терапии

#79

Фармакоэкономический показатель эффективности лечения может выражаться стоимостью одного спасенного года жизни:

при анализе стоимость-прибыль

при анализе стоимость-эффективность

при анализе минимизации стоимости

при анализе стоимость-утилитарность

при анализе прямых затрат на лечение

#80

С точки зрения анализа минимизации стоимости наиболее эффективным будет препарат:

обладающий наибольшей клинической эффективностью при меньшей стоимости

обладающий одинаковой клинической эффективностью, но меньшей стоимостью

обладающий меньшей клинической эффективностью и меньшей стоимостью

обладающий наибольшей клинической эффективностью и большей стоимостью

обладающий меньшей клинической эффективностью и большей стоимостью

#81

С помощью анализа стоимость- эффективность обычно определяют:

какой препарат следует применить, чтобы сэкономить денежные средства

какой препарат следует применить, чтобы получить наибольшую клиническую эффективность

какую сумму денег надо дополнительно затратить, чтобы получить определенное клиническое преимущество

какой препарат дешевле

какой препарат дороже

#82

Фармакоэкономический анализ минимизации стоимости применяется в тех случаях:

когда сравниваемые методы лечения имеют различную стоимость

когда сравниваемые методы лечения имеют различную клиническую эффективность

когда сравниваемые методы лечения имеют одинаковую клиническую эффективность

когда трудно установить клиническую эффективность сравниваемых методов

когда сравниваемые методы лечения имеют одинаковую стоимость

#83

Фармакоэкономический анализ стоимость-утилитарность оценивает:

стоимость одного года спасенной жизни

стоимость одного года жизни, прожитого с абсолютным качеством жизни

стоимость предотвращения одного осложнения

стоимость предотвращения одного осложнения

общественную пользу эффективного лечения

#84

С точки зрения анализа минимизации стоимости наиболее эффективным будет препарат:

обладающий наибольшей клинической эффективностью при меньшей стоимости

обладающий одинаковой клинической эффективностью, но меньшей стоимостью

обладающий меньшей клинической эффективностью и меньшей стоимостью

обладающий наибольшей клинической эффективностью при высокой стоимости

#85

К экономически эффективному лечению можно отнести:

применение блокаторов рецепторов ангиотензина II у больных с мягкой артериальной гипертензией

применение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента у больных с хронической застойной сердечной недостаточностью

применение мегадоз витаминов у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

применение рибоксина у больных дисгормональной миокардиодистрофией

применение витамина E у больных ишемической болезнью сердца

#86

Экономические исходы представляют собой:

совокупность материальных и нематериальных затрат, связанных с выполнением анализируемых фармакотерапевтических вмешательств

регистрируемые лечащим врачом объективные изменения состояния пациента, которые достигаются в результате применения лечения, являясь показателями его эффективности и безопасности

субъективно оцениваемые самим пациентом влияния проведенного лечения на его функциональный статус

оцениваемое качество жизни, которое может измеряться по нескольким критериям

#87

О доказательной и признанной эффективности метода или вмешательства свидетельствует класс клинических рекомендаций:

I класс

IIa класс

IIb класс

III класс

IV класс

#88

Результаты небольших исследований, ретроспективные исследования, общее мнение экспертов соответствует уровню доказательности:

A

B

C

D

E

#89

Результаты нескольких рандомизированных исследований соответствуют доказанности:

A

B

C

D

E

#90

Какой метод фармакоэкономического анализа используется для оценки результатов двух и более альтернативных методов лечения?

Анализ стоимости болезни

Анализ затраты-эффективность

Анализ затраты - полезность

Анализ затраты – выгода

VEN-анализ

#91

Какой метод фармакоэкономического анализа используется для оценки влияния лечения на качество жизни пациента?

Анализ стоимости болезни

Анализ затраты-эффективность

Анализ затраты - полезность

Анализ затраты – выгода

ABC-анализ

#92

К какому классу лекарственных средств будут относиться препараты, на которые затрачено до 80% средств бюджета учреждения?

A

B

C

A и B

#93

К какому классу будут относиться препараты, применения которых при данном заболевании не показано?

V

E

N

V и E

#94

Какой метод фармакоэкономического анализа используется для оценки потерь рабочего времени?

Затраты-эффективность

Затраты - полезность

Затраты - выгода

Моделирование

Анализ стоимости болезни

#95

Потенциальная польза для пациентов от клинических рекомендаций:

улучшение прогноза заболевания, снижение заболеваемости и смертности, улучшение качества жизни или ее отдельных аспектов

улучшение качества клинических решений

основание для повышения эффективности методов лечения

создание стандартов медицинской помощи и протоколов ведения пациентов

рациональное финансирование

#96

Потенциальная польза для врачей от клинических рекомендаций:

улучшение прогноза заболевания, снижение заболеваемости и смертности

улучшение качества жизни или ее отдельных аспектов

улучшение качества клинических решений. КР, созданные на основе доказательной медицины помогают сделать выбор в пользу наиболее эффективных методов или способов лечения, обращают внимание врача на методы с недоказанной эффективностью, а также опасные или в целом бесполезные

создание стандартов медицинской помощи и протоколов ведения пациентов

рациональное финансирование

#97

Потенциальные ограничения для пациентов:

часто возникают ситуации, когда вмешательство, в целом необходимое для популяции или больных с определенной нозологией, не применимо у конкретного пациента

составленные или написанные не соответствующим образом КР могут предоставить врачу неверную научную информацию, ввести в заблуждение при принятии решения

система здравоохранения и страховые компании могут отказаться от использования КР, если это чревато увеличением расходов на дорогостоящие обследования и вмешательства

система здравоохранения и страховые компании могут пострадать при использовании КР, если увеличат расходы на дорогостоящие обследования и вмешательства, не приносящие реальную пользу

#98

Потенциальные ограничения для врачей:

часто возникают ситуации, когда вмешательство, в целом необходимое для популяции или больных с определенной нозологией, не применимо у конкретного пациента

составленные или написанные не соответствующим образом КР могут предоставить врачу неверную научную информацию, ввести в заблуждение при принятии решения

система здравоохранения и страховые компании могут пострадать при использовании КР, если увеличат расходы на дорогостоящие обследования и вмешательства, не приносящие реальную пользу

возможны ситуации, когда клинические рекомендации не содержат решения для пациентов с определенной нозологией или не применимо у конкретного пациента

#99

Потенциальные ограничения для здравоохранения:

часто возникают ситуации, когда вмешательство, в целом необходимое для популяции или больных с определенной нозологией, не применимо у конкретного пациента

составленные или написанные не соответствующим образом КР могут предоставить врачу неверную научную информацию, ввести в заблуждение при принятии решения

система здравоохранения и страховые компании могут пострадать при использовании КР, если увеличат расходы на дорогостоящие обследования и вмешательства, не приносящие реальную пользу

возможны ситуации, когда клинические рекомендации не содержат решения для пациентов с определенной нозологией или не применимо у конкретного пациента

#100

Отхождение от клинических рекомендаций в России

карается в случае наступления общественно опасных последствий

карается всегда

карается исключительно в случае смерти пациента

никак не преследуется

штрафуется работником фомса

#101

Выберите верное утверждение

Актуальные клинические рекомендации размещены на сайте Минздрава

Актуальные клинические рекомендации рассылает раз в год региональный минздрав

Актуальные клинические рекомендации передает клиникам Росздравнадзор в информационных письмах

Актуальные клинические рекомендации издаются в виде сборника для продажи

Актуальные клинические рекомендации служат учебным пособием для среднего медперсонала

#102

Что такое минимальная токсическая доза

максимальное количество препарата, не вызывающее токсическое действие

доза, которая вызывает оптимальное терапевтическое или профилактическое действие у большинства больных

доза, которая вызывает минимальные патофизиологические изменения

доза, которая вызывает летальный исход в 10% наблюдений

доза, которая вызывает интоксикацию или отравление в 50% наблюдений

#103

Выраженность каких побочных эффектов мало зависит от дозы вещества

аллергической природы

неаллергической природы

токсические

канцерогенные

#104

Определить вид нежелательных эффектов лекарственных веществ: мало зависят от дозы, возникают, как правило, при повторных введениях лекарственных веществ:

побочные эффекты неаллергической природы

побочные эффекты аллергической природы

токсические эффекты

идиосинкразия

#105

Привыкание к лекарственному препарату может быть следствием:

Психической зависимости

Повышение метаболизма в печени

Угнетение выведения препарата почками

Активирования молекулы в печени

#106

Привыкание к лекарственному веществу может быть следствием

Индукции микросомальных ферментов печени

Повышения чувствительности рецепторов

Ингибирования микросомальных ферментов печени

Снижение канальцевой секреции в почках

#107

Как называется явление, когда отмена препарата вызывает серьезные психические и соматические нарушения, связанные с расстройством функций многих систем организма вплоть для смертельного исхода

Синдром отдачи

Сенсибилизация

Абстиненция

Идиосинкразия

#108

Определить вид нежелательных эффектов лекарственного вещества: усиливаются с увеличением дозы, возникают при введении вещества в терапевтических дозах:

побочные эффекты связанные в фармакологических свойствами

побочные эффекты аллергической природы

токсические эффекты

идиосинкразия

#109

Что характерно для побочных эффектов аллергической природы:

возникают при использовании вещества в любой дозе

относятся к спектру фармакологического действия лекарственного вещества

обычно возникают при первом введении лекарственного вещества

возникают при использовании вещества в большой дозе

#110

Как называется врожденная гиперчувствительность организма к ЛС:

аллергия

идиосинкразия

тератогенность

эмбриотоксичность

#111

Как называется приобретенная гиперчувствительность организма к ЛС:

идиосинкразия

аллергия

индивидуальная непереносимость

сенсibilизация

#112

Что лежит в основе идиосинкразии:

врожденная патология внутренних органов

тяжелая черепно-мозговая травма

генетически детерминированная недостаточность ферментов

формирование зависимости к лекарственному средству

#113

На какой по счету прием ЛС развивается идиосинкразия:

на первый прием ЛС

на повторный прием ЛС

по завершении курса приема ЛС

не имеет значения

#114

Нежелательные эффекты лекарственного вещества, возникающие при его применении в дозах, превышающих терапевтические, называют:

побочным действием

токсическим действием

идиосинкразией

тератогенным действием

мутагенным действием

#115

Токсическое действие не возникает:

при передозировке

при кумуляции

при патологии печени

при патологии почек

частом применении небольших доз

#116

Терапевтическим лекарственным мониторингом называется:

Контроль за скоростью выведения препарата

Контроль за правильностью введения препарата

Контроль за равновесной концентрацией препарата

Контроль за динамикой концентрации препарата в крови

#117

Для побочных фармакологических эффектов характерно:

Возникают при применении вещества в терапевтических дозах

Их выраженность не зависит от дозы

Их выраженность возрастает с уменьшением дозы

Их выраженность зависит от пути введения препарата

#118

Тератогенное действие — это

Токсическое действие на печень

Отрицательное действие на плод, ведущее к врожденным уродствам

Токсическое действие на кроветворение

Токсическое действие на почки

#119

Мутагенное действие препарата – это:

Действие на сердечно-сосудистую систему

Действие на микросомальные ферменты печени

Действие на половые клетки с изменением генетического аппарата

Действие на основной обмен веществ

#120

О побочном эффекте в фармаконадзор сообщают

не позднее 15 календарных дней со дня, когда стала известна соответствующая информация
в течение 24 ч после получения сведений
не позднее 30 календарных дней со дня, когда стала известна соответствующая информация
если побочный эффект несет угрозу жизни пациента

#121

О смертном случае в результате побочного эффекта в фармаконадзор сообщают

не позднее 15 календарных дней со дня, когда стала известна соответствующая информация
в течении 24 ч после получения сведений
в течении 3 суток после получения сведений
не позднее 7 дней со дня получения информации

#122

Тахифилаксия – это

повышение чувствительности к лекарственному веществу при повторных введениях
необычная реакция на лекарственное вещество при его первом введении
ослабление эффекта лекарственного вещества после его непродолжительного применения
снижение эффекта лекарственного вещества после его введения с небольшими интервалами

#123

Непреодолимое стремление к повторным приемам лекарственного вещества характерно для

кумуляции

тахифилаксии

лекарственной зависимости

привыкания

#124

Фетотоксическое действие – это

неблагоприятное действие на плод, не приводящее к развитию врожденных уродств

неблагоприятное действие на эмбрион, не приводящее к развитию врожденных уродств

действие на эмбрион, приводящее к развитию врожденных уродств

действие на эмбрион, приводящее к развитию опухолей

#125

Мутагенное действие лекарственного вещества – это

неблагоприятное действие на эмбрион, приводящее к врожденным уродствам

повреждение генетического аппарата, приводящее к изменению генотипа потомства

неблагоприятное действие на эмбрион, не вызывающее врожденных уродств

действие на плод, приводящее к развитию опухолей

#126

Наиболее безопасно во время беременности применение следующих антимикробных препаратов

нитрофураны

аминогликозиды

пенициллины

Ко-тримоксазол

фторхинолоны

#127

К отсроченным относится следующая группа побочных эффектов:

токсические

развитие лекарственной зависимости

фармакогенетические

канцерогенные

синдром отмены

#128

Побочные эффекты группы А это:

Прогнозируемые

Непрогнозируемые

Мутагенность, тератогенность, канцерогенность

Зависимость

#129

Побочные эффекты группы В это:

Прогнозируемые

Непрогнозируемые

Мутагенность, тератогенность, канцерогенность

Зависимость

#130

Побочные эффекты группы С это:

Прогнозируемые

Непрогнозируемые

Мутагенность, тератогенность, канцерогенность

Зависимость

#131

Побочные эффекты группы D это:

Прогнозируемые

Непрогнозируемые

Мутагенность, тератогенность, канцерогенность

Зависимость

#132

Источником информации о нежелательных побочных реакциях не являются

спонтанные сообщения

добровольное или законодательно оговоренное информирование регуляторных органов об обнаруженных побочных эффектах

спонтанные сообщения поступающие в службу фармаконадзора от медицинских и фармацевтических работников, производителей ЛС, держателей регистрационных удостоверений на ЛС, а также от потребителей и пациентов

данные медицинских публикаций

#133

Если по результатам мониторинга безопасности будет установлено, что применение ЛС представляет угрозу жизни или здоровью пациентов, министерство здравоохранения РФ принимает решение о/об:

приостановлении применения ЛС

внесении изменений в инструкцию

изъятии из обращения ЛС

повторных клинических исследованиях

#134

Синдром «красной шеи» при быстром внутривенном введении ванкомицина относится к побочным реакциям:

тип А

тип В (аллергические реакции)

тип В (псевдоаллергические реакции)

тип С

тип D

#135

Наркомания относится к побочным реакциям:

тип А

тип В

тип С

тип D

тип E

#136

Укажите, к какому типу побочных реакций относится идиосинкразия:

A

B

C

D

E

#137

Укажите, к какому типу побочных реакций относится анафилактический шок:

A

B

C

D

E

#138

Укажите, к какому типу побочных реакций относится печеночная недостаточность при передозировке парацетамола:

A

B

C

D

E

#139

Укажите, к какому типу побочных реакций относится развившаяся лекарственная зависимость:

A

B

C

D

E

#140

К лекарственной аллергии могут привести все, кроме:

Назначение ЛС в высоких терапевтических дозах

Длительное лечение

Полипрагмазия

Назначение терапевтических доз, на короткий срок лечения

Детский и старческий возраст

#141

Для снижения риска развития НЛР необходимо учитывать все, кроме:

Возраст

Вредные привычки

Образование

Питание

Пол

#142

При приеме каких из перечисленных ЛС может развиваться НЛР в виде лекарственной зависимости

Ненаркотические анальгетики

Барбитураты

Отхаркивающие средства

Муколитики

Антибиотики

#143

Побочные эффекты группы А это:

Прогнозируемые

Непрогнозируемые

Мутагенность

тератогенность, канцерогенность

лекарственная зависимость

#144

Побочные эффекты группы В это:

Прогнозируемые

Непрогнозируемые

Мутагенность

тератогенность, канцерогенность

лекарственная зависимость

#145

Побочные эффекты группы С это:

Прогнозируемые

Непрогнозируемые

Мутагенность

тератогенность, канцерогенность

лекарственная зависимость

#146

К бактерицидным антибиотикам относятся:

цефотаксим

доксциклин

эритромицин

линкомицин

азитромицин

#147

ПРИМЕНЕНИЕ, КАКИХ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНО ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ?

аминогликозиды

Ко-тримазол

нитрофураны

пенициллины

фторхинолоны

#148

ДЕЙСТВИЕ ПЕНИЦИЛЛИНОВ НА БАКТЕРИИ:

бактериостатическое

бактерицидное

бактерицидное или бактериостатическое в зависимости от возбудителя

бактерицидное или бактериостатическое в зависимости от дозы

бактерицидное или бактериостатическое в зависимости от пути введения

#149

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ В СОЧЕТАНИИ С АМОКСИЦИЛЛИНОМ ПОЗВОЛЯЕТ:

защитить амоксициллин от действия пенициллиназ бактерий

защитить амоксициллин от действия бета-лактамаз бактерий

защитить амоксициллин от действия желудочного сока

защитить амоксициллин от действия эндотоксина бактерий

#150

Активны против атипичных возбудителей (микоплазма, хламидии, легионеллы):

макролиды

пенициллины

аминогликозиды

метронидазол

#151

Укажите антибиотик, не обладающий анти-синегнойной активностью:

меропенем

цефазолин

тикарциллин (клавуланат)

ципрофлоксацин

цефтазидим

#152

Какие из перечисленных антибиотиков целесообразно использовать при лечении инфекций, вызванных метициллинчувствительным стафилококком?

бензилпенициллин

ампициллин

оксациллин

амоксциллин

#153

Укажите антибактериальные препараты, обладающие антианаэробной активностью:

гентамицин

хлорамфеникол

бензилпенициллин

метронидазол

цефотаксим

#154

Антимикробная терапия до получения результатов микробиологического исследования:

патогенетическая

этиотропная

эмпирическая

симптоматическая

заместительная

#155

Для возбудителей нозокомиальных инфекций характерно:

более высокий уровень резистентности

легко прогнозировать вид возбудителя до получения результатов бакпосева

флора чаще смешанная

чувствительно к пенициллинам

#156

Антимикробная терапия после получения результатов микробиологического исследования:

патогенетическая

этиотропная

эмпирическая

симптоматическая

заместительная

#157

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ДНЕЙ ПРОВОДИТСЯ ЗАМЕНА АНТИБИОТИКА В СЛУЧАЕ ЕГО НЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

1-2

2-3

5-7

3-4

#158

Какой из перечисленных цефалоспоринов 3 поколения обладает наиболее длительным антибактериальным эффектом?

Цефотаксим (клафоран)

цефтриаксон (роцефин)

Цефтазидим (фортум)

Цефтизоксим (эпоциллин)

Цефоперазон (цефобид)

#159

Укажите препараты, дозы которых можно не корректировать при ХПН:

Гентамицин

цефоперазон

Доксициклин

Цефазолин

Ванкомицин

#160

Выберите группу антибактериальных препаратов для лечения инфекций, вызванных внутриклеточными возбудителями:

макролиды

Пенициллины

Аминогликозиды

Цефалоспорины

Сульфаниламиды

#161

Для возбудителей нозокомиальных инфекций характерно:

более высокий уровень резистентности

Легко прогнозировать вид возбудителя до получения результатов бакпосева

Флора чаще смешанная

Чувствительны к пенициллинам

#162

Для лечения пневмонии антибиотик выбирается с учетом

длительности заболевания

этиологии инфекционного процесса

сопутствующих заболеваний

возраста

объема поражения легочной ткани

#163

Препаратами выбора для лечения пневмококковой пневмонии являются

пенициллины

фторхинолоны

тетрациклины

цефалоспорины

аминогликозиды

#164

Эффективность антибактериальной терапии оценивается через

6 часов

на вторые сутки

через 3 суток

через 7 дней

через 2 недели

#165

Лечение легионеллезной пневмонии проводится

пеницилинами

цефалоспорины

макролидами

тетрациклинами

аминогликозидами

#166

Препаратом выбора для лечения микоплазменных и хламидийных пневмоний является

азитромицин

тинидазол

гентамицин

цефтриаксон

#167

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

ципрофлоксацин

гентамицин

цефотаксим

бензилпенициллин

#168

КАКОЙ МИКРООРГАНИЗМ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЕТ ВНЕБОЛЬНИЧНУЮ ПНЕВМОНИЮ:

микоплазмы

золотистый стафилококк

пневмококк

клебсиелла

#169

Каковы причины появления доказательной медицины:

увеличение объема и доступа к научной информации

нехватка средств, связанная с ростом расходов на здравоохранение

необходимость опереться на индивидуальный врачебный опыт

необходимость опереться на мнение авторитетных экспертов

необходимость опереться на мнение авторитетных врачей

#170

На чем базируется концепция дм:

каждое клиническое решение должно приниматься с учетом научных данных

вес каждого факта тем больше, чем строже методика научного исследования, в ходе которого он был получен

опыте авторитетных врачей

законах российской федерации

индивидуальном мнении эксперта

#171

Чем обусловлена необходимость изучения и овладение принципами доказательной медицины:

неуклонное увеличение объема научной информации

постоянно ощущается нехватка средств, связанная с ростом расходов на здравоохранение, которая усугубляется финансово-экономическим кризисом

из того, что делают врачи и медицинские сестры, лишь 20% обосновано данными клинических испытаний

законом рф

отсутствием индивидуального подхода

#172

В отношении пациента доказательная медицина

никак не влияет

обеспечивает защищённость

снижает защищённость

ухудшает прогноз

улучшает прогноз

#173

Доказательная медицина

мешает работе врача

незначительно упрощает работу врача

никак не влияет на работу врача

сильно упрощает работу врача

повышает качество работы врача

#174

Доказательные данные в настоящее время

никак не соотносятся с практической медициной

применяются только в научных исследованиях

являются основой медицинского процесса

служат основой для составления клинических рекомендаций

являются базой для обновления учебников

#175

Соотнесите основные принципы подходов в клинической практике врача:

традиционный подход=знания о заболевании, диагностических тестах и эффективности лечения основаны на бессистемных клинических наблюдениях самого врача и отдельных экспертов\единственное руководство для принятия клинических решений – знания об основных механизмах заболевания и патофизиологических принципах

принцип доказательной медицины=использование систематических клинических наблюдений для принятия решений\правильная интерпретация и использование научной литературы для принятия клинических решений и стратегии лечения\новый подход придает меньшее значение авторитету отдельных экспертов, но не отвергает его. Врачам следует критически анализировать любую информацию, прежде чем использовать ее в работе с пациентами

#176

Сопоставьте ученых и их вклад в развитие доказательной медицины:

Бруссе=кровожаднейший врач в истории медицины

Кокран=разработал технологию выполнения мета анализа клинических исследований, систематический обзор

Гавар=начал внедрять в медицинскую практику методы статистического анализа результатов вмешательств

Фибигер=первое описание контролируемых исследований

Луи=внедрил в клиническую практику количественный метод оценки эффективности профилактических и лечебных подходов

#177

Соотнесите вид вмешательства и его обоснованность:

обоснованный вид вмешательства=антибиотики для лечения хеликобактер пилори\антикоагулянты при инфаркте миокарда

необоснованный вид вмешательства=рибоксин при заболеваниях сердца\кровопускание при дизентерии\лоботомия при шизофрении

#178

Упорядочите пять основных шагов для работы врача в рамках доказательной медицины в порядке возрастания:

1=четкая формулировка клинического вопроса

2=поиск научной литературы. Хороший источник информации содержит высококачественные данные о пользе и рисках всех возможных вмешательств, клинически применим и удобен для пользователя

3=критическая оценка информации: валидности, клинической значимости и применимости результатов исследований

4=применение полученной информации в практике. Вопросы, которые важно задать перед принятием клинического решения: похожи участники исследования на моего пациента? Доступно ли предложенное лечение? Какие есть альтернативы? Какие риски для пациента?

5=оценка результата. Важно оценить, как использование данных исследований повлияло на пациента и насколько это соответствует результатам этих исследований

#179

Добиться однородности основной и контрольной групп Лечения позволяют методы стратификации

ослепления

плацебо-контроля

рандомизации

статистики

#180

К истинным критериям относятся:

уровень АД

уровень ЧСС

смерть

улучшение качества жизни

уровень холестерина

#181

К суррогатным критериям относятся:

АД

ЧСС

смерть

улучшение качества жизни

выздоровление

#182

Формирование выборки основано на критериях:

включения

обоснования

исключения

формирования

рандомизации

#183

Недостатками исследования в параллельных группах являются

высокая затратность

необходимость большого числа анализируемых характеристик

необходимость включения большого количества больных

смешение эффектов разных видов лечения

отсутствие контрольной группы

#184

К серьезным нежелательным явлениям безусловно относятся

появление аномальных значения лабораторных показателей

угрожающее жизни состояние

смерть

продление текущей госпитализации

снижение аппетита

#185

Цели III фазы клинических исследований:

Подтверждение эффективности

Мониторинг побочных эффектов

Расчёт себестоимости

Разработка рекламы

Подтверждение безопасности у широкой популяции

#186

Какие группы подвергаются исследованиям в клинических фазах?

Здоровые добровольцы

Пациенты с заболеванием

Ветеринары

Лаборанты

Производители

#187

Какие из следующих требований обязательны перед началом клинических испытаний?

Одобрение этического комитета

Регистрация в Минздраве

Подписание информированного согласия

Наличие рекламы

Обсуждение с фарм компаниями

#188

Что изучается на доклиническом этапе?

Тератогенность

Канцерогенность

Острая токсичность

Влияние на маркетинг

Стоимость препарата

#189

Методы, применяемые в доклинических исследованиях:

In vitro

In vivo

In silico

Информированное согласие

Сравнение с конкурентами

#190

Соотнесите фазу клинических исследований и ее характеристики:

1 фаза=Изучение фармакокинетики у пациентов\Исследования на здоровых добровольцах (50-100 человек)

2 фаза=Первые контролируемые исследования на больных 100-300 человек

3 фаза=Рандомизированные двойные слепые контролируемые исследования на больших группах пациентов (1000- 3000 человек)

4 фаза=Дополнительное изучение эффективности и безопасности препарата в процессе его рутинного использования

#191

Соотнесите роли участников исследований:

Спонсор=Организация и финансирование

Этический комитет=Контроль этики и защиты прав

Доброволец=Участие в испытании

Исследователь=Проведение испытания по протоколу

Пациент=Проведение испытания по протоколу

#192

ПРИЧИНЫ «ВЫПАДЕНИЯ» ПАЦИЕНТОВ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Низкий комплаенс у пациента к препарату

Исключение пациента врачом по клиническим показаниям

Невозможность последующего наблюдения

Смерть

высокие расходы на исследование

#193

Какие указатели используются в поисковике:

указатель немедицинских предметных рубрик (nonmeshtranslationtable)

указатель журналов (journalstable)

указатель фраз (phraselist)

авторский указатель (authorindex)

указатель страны

#194

Описательные исследования (количественные)

обзор и оценка использования лекарственных средств

обзоры потребления лекарственных средств

программы использования лекарственных средств

стоимость лечения

стоимость болезни

#195

К источникам информации доказательной медицины относятся:

материалы публикаций в научно-популярных изданиях

систематические обзоры

краткие обзоры

системные источники информации: статьи, практические руководства, справочники
доказательной медицины

литературные обзоры

#196

К аналитическим исследованиям относятся:

анкетирование

экспериментальные

обсервационные

поперечные

интервью

#197

К описательным исследованиям не относятся:

история болезни исследования

экспериментальные

обсервационные

корреляционные

анкетирование

#198

cochrane library состоит из:

кокреновский регистр контролируемых исследований

база данных кокреновских систематических обзоров

база литературных обзоров

база данных, посвященная научному синтезу, принципам и методологии проведения систематических обзоров

база данных успешных случаев

#199

В клиническом вопросе отражены следующие составляющие:

вмешательство (предпринимаемые меры воздействия)

сравнение вмешательств (воздействий)

исходы (результаты)

анализ ситуации

стоимость вмешательства

#200

К обсервационным исследованиям относятся:

«случай-контроль»

когортные

сообщения о случаях

одномоментные

перпендикулярные

#201

Требования к структуре исследования:

наличие контрольной группы

ясные критерии отбора (включения и исключения) больных

включение больных в исследование до рандомизации

не случайный(специальный) метод распределения больных по группам

включение в группы больных разного возраста

#202

Требования к структуре исследования:

длительность

"слепое" лечение

"слепая" оценка результатов лечения

неясные критерии отбора

хороший результат исследования

#203

Причины «выпадения» пациентов из клинических испытаний

отсутствие ожидаемого эффекта в процессе испытания

подозрение на побочный эффект от приема экспериментального лекарственного препарата
снижение мотивации у пациента («я не хочу больше принимать эти таблетки»)
исключение пациента врачом по клиническим показаниям
снижение комплаенса (приверженности к лечению) в процессе испытания

#204

Установите правильную последовательность в порядке убывания иерархии доказательной медицины:

- 1=Систематический обзор и метаанализ
- 2=Рандомизированных клинических исследований
- 3=Когортные исследования
- 4=Исследования типа «случай контроль»
- 5=Сообщение об отдельных случаях

#205

Установите соответствия между фазой клинического исследования и характеристикой:

- I ФАЗА=установить безопасность и определить фармакокинетический и ФД профили у человека
- II ФАЗА=оценить эффективность и краткосрочную безопасность у пациентов с заболеванием, для лечения которого и предполагается использовать новый препарат, а также определить режимы дозирования
- III ФАЗА=установить баланс между безопасностью и эффективностью и определить общую и относительную терапевтическую ценность в условиях, близких к реальному использованию
- IV ФАЗА=изучить отдаленную безопасность, получить сведения о редких нежелательных реакциях\выработать стратегию дальнейшего развития препарата

#206

Установите соответствия между видом клинического исследования и его характеристикой:

Обсервационное исследование=исследование, в котором изначально объединенную каким-либо общим признаком выделенную группу людей наблюдают в течение некоторого времени и сравнивают исходы у тех, кто был и не был подвергнут действию изучаемого вмешательства или другого фактора, либо был подвергнут ему в разной степени

Описание серии случаев=исследование, в котором представлен количественный анализ (чаще всего с применением описательной статистики) группы больных численностью 10 человек и более

Исследование «случай — контроль»=ретроспективное исследование, в котором по архивным данным, воспоминаниям или суждениям пациентов сравнивают две группы: в одну отобраны пациенты с определенной патологией, а в другую — без нее

Когортное исследование=Проспективное исследование, которое используется для выявления причин заболевания, установления связей между факторами риска и их последствий для здоровья

Исследование до-после=Исследование, в ходе которого сравнивают состояние участников до и после изучаемого вмешательства

#207

При составлении формуляра прежде всего, необходимо собрать информацию об использовании лекарств в больнице:

годовой бюджет на лекарственные закупки

процентное соотношение бюджета на лекарственные закупки и общего годового бюджета больницы

общее количество используемых больницей лекарственных средств

стоимость дженериков использованных в прошлом году

количество пациентов

#208

ВОЗМОЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕПАРАТА:

Ограничения по диагнозу

Ограничения по уровню квалификации

Фармакологические ограничения

Этические ограничения

Локальныеограничения

#209

ФТК решает следующие вопросы:

критерии отбора лекарственных препаратов для формуляра

внесение и исключение лекарств из формуляра

требования к заполнению листов назначений

использование клинических рекомендаций

стоимости лекарств

#210

Разработка формулярного списка лекарственных средств включает:

Анализ структуры заболеваемости и состояния лекарственного обеспечения

Отбор лекарственных средств для формулярного списка

Утверждение формулярного списка лекарственных средств

Установление поставщиков лекарственных средств

Штатное расписание фармацевтической службы

#211

Соотнесите торговые и генерические названия препаратов:

аспирин\нурофен\найз=торговое

ацетилсалициловая кислота\амоксциллин=генерическое

#212

Целью введения формулярной системы в больнице является:

оптимизация фармакотерапии

снижение числа врачебных ошибок

обеспечение соответствия между государственными обязательствами, финансовыми возможностями и бюджетными затратами

Повышение квалификации врачей

Улучшение комплаентности пациентов

#213

Правила работы формулярно-терапевтической комиссии (ФТК) следующие:

обоснование потребности в лекарственных средствах

стоимость лекарственного средства должна быть оправдана его эффективностью и безопасностью

исключение из формуляра дублирующих лекарственных средств

Расширение списка дженериков

Составление клинических рекомендаций

#214

Упорядочите этапы создания формулярного списка:

1=собрать данные о заболеваемости (в идеале, 50 основных нозологий) в порядке убывания числа случаев по каждой нозологии

2=подсчитать процент каждого из 50 заболеваний по отношению к общему числу заболеваний

3=выбрать лекарства (и данные об их стоимости), которые были использованы для лечения 50 главных заболеваний

4=подсчитать процент их стоимости по отношению к стоимости всех лекарственных закупок за исследуемый период

5=ABC и VEN анализ

#215

Соотнесите торговые и генерические названия препаратов:

осельтамивир\ампициллин=генерическое

меронем\димедрол\омез=торговое

#216

Причины использования генерических наименований:

генерические наименования более информативны, чем фирменные, и отражают принадлежность к определенному классу и химической структуре

назначение генерических препаратов позволяет больничному провизору проводить генерическую замену, тогда как фирменная номенклатура обязывает отпускать только указанное в рецепте средство

генерические наименования позволяют закупать препараты у различных поставщиков и, как правило, дешевле фирменных

легче записывать

они эффективнее чем оригинальные препараты

#217

Классификации исходов (концепция echo):

экономические

клинические

гуманистические

промежуточные

отрицательные

#218

Лечение с большей стоимостью будет менее экономически эффективным, чем лечение с меньшей стоимостью:

когда лечение имеет одинаковую клиническую эффективность

когда лечение имеет большую клиническую эффективность

когда лечение имеет меньшую клиническую эффективность

во всех случаях

когда клиническую эффективность определить невозможно

#219

Сопоставьте виды затрат по категориям

фармакотерапия\врачебные манипуляции=Прямые

оплата больничного листа\расходы социальных служб=Непрямые

физические, психические способности=Нематериальные

#220

Прямые затраты на лечение включают:

затраты на приобретение лекарственных препаратов

затраты, связанные с использованием оборудования

затраты на оплату труда медицинских работников

Затраты, связанные с потерей производительности

Стоимость непроизведенной пациентом продукции выберите правильный

#221

Нематериальные затраты включают:

эмоциональные переживания пациента, связанные с болезнью

психологические аспекты болезни

затраты, связанные с терапией

затраты, связанные с использованием оборудования

затраты на оплату труда медицинских работников

#222

Для кого предназначена результаты фармакоэкономического анализа:

родственников

организаторов

здравоохранения

пациента

врача

#223

Установите соответствие между методами терапии и видом фармакоэкономического анализа:

метод минимизации затрат=сравнение терапии цефтриаксоном и цефазолином\сравнение терапии имипенем 500 мг и имипенем 1г

метод затраты эффективность=терапия омепразолом и ранитидином\терапия различные схемы терапии хеликобактер пилори\сравнение терапии артериальной гипертензии ИАПФ и бета-адреноблокаторами

#224

К основным методам фармакоэкономического анализа относят:

ABC анализ

VEN анализ

метод минимизации затрат

метод затраты эффективность

затраты выгода

#225

Установите соответствие между методами фармакоэкономического анализа и их определением:

анализ минимизации затрат=сравнения стоимости двух и более вмешательств с равной клинической эффективностью

анализ затраты эффективность=сравнение стоимости двух и более вмешательств, неодинаковых по эффективности и/или безопасности

анализ «затраты-выгода»=определение финансовой выгоды по отношению к затратам

анализ «затраты-полезность»=определение соотношения стоимости лечения и его полезности, который основан на всестороннем и комплексном изучении качества жизни и его связи со степенью здоровья пациента

ABC-анализ=метод оценки рациональности расходования денежных средств путем распределениякупаемых лекарственных препаратов по трем классам в соответствии с их фактическим потреблением за определенный предыдущий период времени

#226

Упорядочите расчет полезности затрат по этапам:

1=Количественное определение субъективной прогностической оценки предпочтений, даваемой пациентом различным состояниям здоровья

2=Вычисление интегрированного показателя полезности вмешательства с учетом продолжительности периода времени, для которого он был получен

3=Вычисление соотношения затрат (cost), необходимых для проведения данного лечения и его гипотетической полезности (U_t), выражаемой показателем QALY

4=Оценка экономической приемлемости терапии при расчете на один год жизни с абсолютным качеством

#227

Клинические рекомендации содержат

информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

последовательности действий медицинского работника

схем диагностики и лечения в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний

Схему патогенеза заболевания

#228

Цель создания КР

обеспечение информационной поддержки принятия врачом решений

повышение качества оказания медицинской помощи пациенту с тем или иным заболеванием/состоянием/синдромом

учёт новейших клинических данных и принципов доказательной медицины

Повышение заболеваемости населения

Снижение качества жизни больных

#229

В состав рабочей группы для обеспечения междисциплинарного подхода могут входить:

врачи-специалисты – представители основных медицинских специальностей

клинические фармакологи, эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинский реабилитолог, клинический лаборант, функциональный диагност, профпатологи, судебно-медицинские эксперты, организаторы здравоохранения, медицинские сестры и т.д.

научные сотрудники

специалисты в области информационных технологий, социальные работники

Преподаватели медицинских вузов

#230

Какие утверждения верны?

Клинические рекомендации (КР) являются результатом длительной совместной работы специалистов

КР утверждаются профессиональными медицинскими обществами

КР предназначены для медицинских работников и организаторов здравоохранения

КР можно использовать для терапии редких заболеваний

КР нельзя использовать для разработки критериев качества и управления лечебно-диагностическим процессом

#231

Основные принципы разработки клинических рекомендаций (КР):

КР не могут противоречить действующему законодательству и нормативно-правовым документам в сфере здравоохранения Российской Федерации

КР разрабатываются и пересматриваются с учётом принципов доказательной медицины

КР пересматриваются не реже 1 раза в 3 года

КР пересматриваются не реже 1 раза в 5 лет

разрабатываются по инициативе ученых

#232

Какие утверждения верны?

КР доступны для медицинских работников на всей территории Российской Федерации

КР размещаются в глобальной сети Интернет на общедоступном информационном ресурсе

Сборники КР продаются через книжные магазины

КР хранятся в городских библиотеках

КР разрабатываются сообществами ученых и практических врачей

#233

Соотнесите класс рекомендаций и его характеристику

Класс I=Польза и эффективность диагностического метода или лечебного вмешательства доказаны и/или общепризнаны

Класс II=Противоречивые данные и/или расхождение мнений по поводу пользы/эффективности метода лечения

Класс IIa=Имеющиеся данные свидетельствуют о пользе/эффективности лечебного вмешательства

Класс IIb=Польза/эффективность менее убедительны

Класс III=Имеющиеся данные или общее мнение свидетельствуют о том, что лечение бесполезно/не эффективно и в некоторых случаях может быть вредным

#234

Упорядочите этапы ведения пациента с внебольничной пневмонией:

1=обследование и постановка диагноза

2=определение необходимости госпитализации

3=определение рисков резистентности и сопутствующих заболеваний

4=подбор антибактериальной терапии

5=контроль эффективности и безопасности антибактериальной терапии

#235

Какие утверждения верны?

Клинические рекомендации (КР) должны разрабатываться на основе принципов доказательной медицины

КР разрабатываются и утверждаются медицинскими профессиональными некоммерческими организациями

КР разрабатываются по отдельным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)

КР разрабатываются для экспертов ФОМСа

КР служат учебным пособием для студентов

#236

Типы аллергических реакций:

реакция немедленного типа

реакции замедленного типа

цитотоксическая

иммунокомплексная

псевдоаллергическая

#237

Побочные эффекты группы D это:

непрогнозируемые

мутагенность

тератогенность

канцерогенность

лекарственная зависимость

#238

К антибиотикам группы карбапенемов относятся:

карбенициллин

имипенем

меропенем

азтреонам

циластатин

#239

Особенности аллергических реакций на применение ЛС:

отличаются от фармакологических эффектов

могут носить перекрестный характер

не коррелируют с дозой препарата

не отличаются от фармакологических эффектов

не могут носить перекрестный характер

#240

Лекарственная аллергия:

нежелательна

относится к побочным эффектам

возникает даже в терапевтических дозах

все перечисленное

возникает при введении больших доз препарата

#241

Побочные действия, зависящие от дозы препарата:

фармакодинамические

аллергические

токсические

фармакоэкономические

фармакокинетические

#242

Побочные эффекты витамина С включают:

образование оксалатных камней в почках

образование холестериновых камней в почках

повышение клиренса мочевой кислоты

лейкопению

эритроцитоз

#243

Строго дозозависимыми являются следующие группы побочных эффектов:

фармацевтические

токсические

Аллергические

мутагенные

синдром отмены

#244

Для уменьшения риска развития побочного действия следует учитывать:

принадлежность препарата к определенной фармакологической группе

возраст пациента

функциональное состояние органов и систем, участвующих в биотрансформации лекарственного средства и выведении препарата

стоимость препарата

наличие сопутствующих заболеваний

#245

Установите соответствие между видами отрицательного действия и ситуацией:

аллергия=У больного ревматизмом, принимающего бензилпенициллина развилось удушье, отек губ и сыпь на коже

отрицательное действие, связанное с фармакодинамикой=У больного с сахарным диабетом, принимающего инсулин, развилась гипогликемия\У больного при проведении операции в качестве анальгезирующего средства использован морфин в терапевтических дозировках произошло угнетение дыхания

канцерогенное действие лекарств=У больного, длительное время проводившего терапию дерматита, развился рак кожи

привыкание=Больной, страдающий нарушением акта засыпания, принимает в течение четырех дней снотворный препарат – нитразепам. На пятый день больной отметил, что препарат оказал эффект только при увеличении дозы

#246

Установить правильную последовательность патогенеза 1 типа аллергических реакций:

1=попадание препарата в организм

2=выработка антител класса IgE

3=образование иммунного комплекса и оседание его на тучных клетках

4=дегрануляция тучных клеток, с выходом медиаторов воспаления

5=клинические проявления

#247

Чем характеризуются тератогенные нежелательные явления?

Нарушениями процессов эмбриогенеза и возникновением аномалий развития

генетически predetermined аномальные реакции на лекарственное средство

влиянием на плод в 1 триместре беременности

Развитиями аллергических реакций при применении определенных лекарственных препаратов

Развитие аномалий развития совместимых с жизнью

#248

Что подразумевает собой понятие толерантность в фармакотерапии?

потерю или ослабление эффекта препарата во время его регулярного применения

привыкание к препарату

ухудшение течения болезни после внезапной отмены лекарственного средства

ухудшения эффекта препарата, связанного с изменением течения самого заболевания

отсутствие эффекта при начале введения препарата у отдельных пациентов

#249

При отмене каких препаратов развивается синдром отмены?

антибиотиков

глюкокортикоидов

барбитуратов

противовирусных

наркотических анальгетиков

#250

Как влияют курение и алкоголь на эффективность и безопасность лекарств?

Курение усиливает метаболизм лекарств, что может ослабить их эффекты

Курение снижает абсорбцию лекарств

Алкоголь не влияет на их эффективность

Курение и алкоголь не оказывают значимого влияния на лекарства

Алкоголь повышает риск гипотонии при приеме антигипертензивных препаратов

#251

Какие особенности фармакокинетики и фармакодинамики следует учитывать при назначении лекарств пожилым пациентам?

Увеличение всасывания и метаболизма препаратов

Снижение секреторной функции пищеварительных желез

Повышение почечной экскреции лекарств

Снижение моторной и всасывательной функции ЖКТ

Усиление чувствительности к препаратам без изменений фармакокинетики

#252

О чем свидетельствует малое число побочных эффектов у препарата?

О его высокой безопасности

О его низкой безопасности

О его низкой эффективности

О его высокой эффективности

#253

Что относится к побочным реакциям?

сонливость при приеме антигистаминных препаратов

прекращение кашля при приеме противокашлевых препаратов

снижение давления при приеме гипотензивных средств

гипокалиемия при приеме диуретиков

выраженная слабость при отмене глюкокортикоидов

#254

Классификация побочных эффектов лекарственных средств. Сопоставьте типы побочных эффектов с их описаниями:

Фармакодинамические=Связаны с фармакологическими свойствами ЛС, такие как ортостатические реакции при антигипертензивных средствах

Токсические=Обычно дозозависимые, связаны с токсичностью для жизненно важных органов

Аллергические (псевдоаллергические)=Непредсказуемые, часто связаны с аллергенностью определенных групп ЛС

Идиосинкразия=Редкие генетически predetermined аномальные реакции на ЛС

Тератогенные и эмбриотоксические=Влияют на развитие плода, изучаются в экспериментах на животных

#255

Побочные эффекты и явления, связанные с приемом лекарств. Сопоставьте понятия с их описаниями:

Идиосинкразия=Генетически обусловленная патологическая реакция на определенный лекарственный препарат, возникающая при первом контакте

Синдром отмены (рикошета)=Ухудшение течения болезни после внезапной отмены лекарственного средства

Лекарственная зависимость=Тяжелое психосоматическое состояние, требующее возобновления приема лекарственного средства, характерно для психотропных и наркосодержащих препаратов

Канцерогенность=Побочные эффекты ЛС, вызывающие развитие злокачественных опухолей

Мутагенность==Побочные эффекты ЛС, приводящие к развитию генетических нарушений и болезней

#256

Какие вопросы должен задать себе врач перед медицинским вмешательством?

следует ли вмешиваться назначением лекарства в течение заболевания?

какие нежелательные лекарственные реакции могут возникнуть в ходе лечения?

является ли доза лекарства адекватной состоянию пациента

хочет ли принимать пациент данный препарат?

согласна ли семья пациента с назначением данного препарата?

#257

Фармакотерапию каких отдельных групп пациентов надо учитывать при назначении определенного вмешательства?

подростков

беременных

употребляющих кофе

старших возрастных

новорожденных

#258

Какие нежелательные явления могут возникнуть в ходе лечения выбранным препаратом?

токсические

терапевтические

лечебные

идиосинкразия

аллергические

#259

Для каких препаратов характерно развитие лекарственной зависимости?

антиангинальных

бронхолитиков

психотропных

глюкокортикоидов

бета-блокаторов

#260

Для каких препаратов характерно развитие привыкания?

витаминов

барбитуратов

муколитиков

слабительным

сосудосуживающих ЛС

#261

Что включает в себя алгоритм, которого должен придерживаться врач, в выборе и подборе препаратов с позиций доказательной медицины?

определение терапевтической мишени

определение стоимости лечения

возможно ли добиться поставленной цели избранным лекарственным средством

определение соотношения «риск-польза»

определение стоимости болезни

#262

Что входит в нежелательные лекарственные явления при терапии?

тератогенные эффекты

генетические явления

идиосинкразия

клинические явления

аллергия

#263

К нежелательным лекарственным явлениям относится:

аллергические

токсические

фармакодинамические

фармакоклинические

лекарственная зависимость

#264

Побочные реакции у беременных могут вызывать дозы:

лечебные

повышенные

местные

профилактические

рекомендованные

#265

Что такое резистентность?

непереносимость препарата

привыкание к препарату

невосприимчивость к препарату

зависимость от препарата

снижение эффекта в процессе терапии

#266

Лечение внебольничной пневмонии у лиц молодого возраста следует начинать с

цефалоспоринов

гентамицина

фторхинолонов

карбопенемов

макролидов

#267

Внебольничная пневмония – это:

пневмония, которая развилась вне стационара

Через 3 дня после поступления в стационар

Через 5-6 дней после поступления в стационар

через 1 день после поступления в стационар

через 6 мес после пребывания в стационаре

#268

Внутрибольничная пневмония это:

пневмония, которая развилась вне стационара

пневмония, которая развилась через 3 дня после поступления в стационар

пневмония, которая развилась через 5-6 дней после поступления в стационар

пневмония, которая развилась через 1 день после выписки из стационара

пневмония, которая развилась у сотрудников стационара

#269

Показания для смены антибиотика или назначения второго антибактериального препарата:

Клиническая неэффективность лечения через 48-72 ч от начала лечения

Микробиологическая эффективность при отсутствии клинического улучшения

Индивидуальная непереносимость антибактериального препарата

Возможность развития нежелательных лекарственных явлений, связанных с длительным курсом антибактериального лечения

Улучшение состояния на третьи сутки

#270

Критерии отмены антибактериального лечения при лечении внебольничной пневмонии

Температура тела $<37,5^{\circ}\text{C}$. и отсутствие интоксикации

Дыхательная недостаточность

Гнойный характер мокроты

Лейкоциты крови $<10 \times 10^9$; нейтрофилы $<80\%$; палочкоядерные нейтрофилы $<6\%$

Отсутствие отрицательной динамики на рентгенограмме

#271

Установите алгоритм стратегии выбора и назначения лекарственных средств с позиций доказательной медицины:

1=определение терапевтической мишени

2=возможность достижения поставленной цели избранным лекарственным средством

3=оценка соотношения «риск-польза» при назначении избранного препарата

4=учет фармакотерапии отдельных групп пациентов

5=учет влияния курения и алкоголя на эффективность и безопасность лекарственной терапии

#272

Установите последовательность, в которой врач назначает ЛС, руководствуясь принципами «рациональной фармакотерапии»:

1=определение терапевтической мишени

2=определение сроков лечения

3=прогнозирование возможных НЛР

4=учет особенностей фармакотерапии у беременных и лиц старшего возраста

5=учет влияния курения и алкоголя на эффективность ЛС